

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ÍNDICE DE ACULTURACIÓN DE VANCOUVER (VIA)

Eje III: Personalidad • Modelo Bidimensional de Aculturación: Dimensión de Herencia vs. Mayoritaria

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Índice de Aculturación de Vancouver (VIA).
Nombre Original	Vancouver Index of Acculturation (VIA; Ryder, Alden & Paulhus, 2000).
Autores Originales	Andrew G. Ryder, Ph.D., Lynn E. Alden, Ph.D. y Delroy L. Paulhus, Ph.D. (UBC, Canadá).
Adaptación Hispana	Ozer (2015); Martínez et al. (2018); España y Latinoamérica.
Eje Clínico y Constructo	Eje III: Personalidad / Identidad. Modelo bidimensional ortogonal de aculturación.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 20 reactivos balanceados emparejados en escala Likert de 9 puntos (1 a 9).
Población y Rango	Adolescentes y adultos migrantes, refugiados o de minorías culturales (desde 14 años).
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos de autoadministración sencilla.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación bajo citación formal (copyright APA).

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL MODELO BIDIMENSIONAL DE ACULTURACIÓN

El **Índice de Aculturación de Vancouver (VIA)** operacionaliza el modelo bidimensional de aculturación de John Berry (1997) desarrollado psicométricamente por Ryder, Alden y Paulhus (2000). El paradigma tradicional unidimensional asumía erróneamente que la asimilación a una nueva cultura requería la pérdida obligatoria de la cultura de origen. El modelo bidimensional postula la total **independencia y ortogonalidad** de dos orientaciones identitarias:

- Dimensión de Herencia Cultural (Heritage):** Mantenimiento de las tradiciones, valores nucleares, prácticas sociales, idioma de origen y orgullo colectivo vinculado a la comunidad de procedencia.
- Dimensión Dominante / Receptora (Mainstream):** Adopción activa de pautas culturales, participación ciudadana, relaciones sociales y estilos de vida propios de la sociedad de acogida.

La interacción cartesiana de ambas dimensiones define cuatro estrategias de adaptación con profundas implicaciones para la salud mental: *Integración (biculturalismo)*, *Asimilación*, *Separación* y *Marginación*.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (PARES PARALELOS)

El instrumento consta de **10 pares paralelos de reactivos** (20 ítems en total) que exploran las mismas áreas vitales:

Área Vital Evaluada	Ítem Herencia	Ítem Cultura Dominante (Mainstream)
1. Tradiciones y festividades	Ítem 1 (Tradiciones origen)	Ítem 2 (Tradiciones sociedad de acogida).
2. Amistades e interacción social	Ítem 3 (Amigos origen)	Ítem 4 (Amigos sociedad de acogida).
3. Mantenimiento de valores	Ítem 5 (Valores de origen)	Ítem 6 (Valores de sociedad de acogida).
4. Medios y entretenimiento	Ítem 7 (Música/cine origen)	Ítem 8 (Música/cine sociedad de acogida).
5. Sentido del humor y bromas	Ítem 9 (Humor origen)	Ítem 10 (Humor sociedad de acogida).
6. Relaciones afectivas y pareja	Ítem 11 (Pareja origen)	Ítem 12 (Pareja sociedad de acogida).
7. Actividades recreativas	Ítem 13 (Ocio cultura origen)	Ítem 14 (Ocio sociedad de acogida).
8. Conducta cotidiana	Ítem 15 (Estilo origen)	Ítem 16 (Estilo sociedad de acogida).
9. Comodidad relacional	Ítem 17 (Confort grupo origen)	Ítem 18 (Confort grupo de acogida).
10. Apego e identidad subjetiva	Ítem 19 (Identidad origen)	Ítem 20 (Identidad sociedad de acogida).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y CLASIFICACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

Diversos estudios transculturales (Ozer, 2015; Huynh et al., 2018) respaldan la validez de la versión en español del VIA:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Herencia	Alfa $\alpha = 0.88 - 0.92$	Excelente homogeneidad en la subescala de vinculación a la cultura de origen.
Consistencia Dominante	Alfa $\alpha = 0.85 - 0.89$	Alta confiabilidad interna en la escala de adhesión a la sociedad de acogida.
Ortogonalidad Demostrada	Correlación $r = 0.02 - 0.12$	Confirma empíricamente la independencia total entre ambas dimensiones de identidad.
Validez Estructural	CFA Bidimensional	Ajuste sobresaliente del modelo de dos factores independientes (CFI > 0.95, RMSEA < 0.05).
Validez de Criterio	$r = -0.35$ a -0.45	La biculturalidad (Integración) se asocia a menor depresión, menor ansiedad y mayor bienestar.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE SUBESCALAS

- **Puntuación de Ítems:** Escala Likert de 9 puntos que abarca desde Totalmente en desacuerdo (1) hasta Totalmente de acuerdo (9).
- **Cálculo de la Dimensión Herencia (Heritage):** Se suman los 10 reactivos impares (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) y se divide entre 10:

$$\text{Media Herencia} = \frac{\sum \text{Ítems Impares}}{10} \quad (\text{Rango: 1.00 a 9.00 puntos})$$

- **Cálculo de la Dimensión Dominante (Mainstream):** Se suman los 10 reactivos pares (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) y se divide entre 10:

$$\text{Media Dominante} = \frac{\sum \text{Ítems Pares}}{10} \quad (\text{Rango: 1.00 a 9.00 puntos})$$

- **No existe Puntuación Total Global:** Sumar ambas dimensiones carece de validez teórica y clínica, pues cancelaría la bidimensionalidad del constructo.

6. CLASIFICACIÓN EN CUADRANTES DE ACULTURACIÓN (PUNTO DE CORTE 5.00)

Utilizando el punto medio teórico de la escala Likert (5.00 puntos) o la mediana de la muestra, se clasifican los 4 cuadrantes de adaptación:

Estrategia Berry	Herencia	Cultura Receptora	Pronóstico Psicosocial y Salud Mental
Integración	Alta (≥ 5.0)	Alta (≥ 5.0)	Biculturalismo óptimo; mayor resiliencia, menor estrés aculturativo y alta competencia.
Asimilación	Baja (< 5.0)	Alta (≥ 5.0)	Ruptura con la raíz familiar; riesgo de conflicto generacional y de sapego identitario.
Separación	Alta (≥ 5.0)	Baja (< 5.0)	Encapsulamiento etnocultural; barreras en inserción laboral y distanciamiento social.
Marginación	Baja (< 5.0)	Baja (< 5.0)	Anomia identitaria; máximo riesgo de sintomatología depresiva, adicciones y desamparo.

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA DEL CUADRANTE DE MARGINACIÓN (AMBAS MEDIAS < 4.00):

Puntuaciones inferiores a 4.00 tanto en Herencia como en Mainstream revelan un colapso del sentido de pertenencia colectiva (anomia identitaria o “doble exclusión”), constituyendo un factor de riesgo cardinal para ideación suicida y cuadros depresivos mayores en población migrante.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MEDIACIÓN PSICOTERAPÉUTICA TRANSCULTURAL

PROTOCOLO DE ABORDAJE CLÍNICO DE LA DISONANCIA ACULTURATIVA:

- **Paso 1 (Mapeo de Coordenadas Identitarias):** Calcular las dos medias del VIA y ubicar al paciente en el cuadrante de Berry correspondiente.
- **Paso 2 (Exploración de Brechas Familiares Intergeneracionales):** Si el paciente es segunda generación y presenta Asimilación (alta Mainstream, baja Herencia) mientras los padres sostienen Separación, focalizar la intervención en la renegociación de normas familiares y desculpabilización.
- **Paso 3 (Intervención en Caso de Marginación):** Conectar activamente al consultante con redes comunitarias tanto de su comunidad de origen como de la sociedad receptora; validar el duelo migratorio y reconstruir narrativas de continuidad del yo.
- **Paso 4 (Promoción del Biculturalismo Integrado):** Estimular la flexibilidad conductual que permita transitar entre ambos códigos culturales sin vivencia de traición identitaria ni inferioridad social.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DUELO MIGRATORIO COMPLEJO Y AISLAMIENTO SOCIAL

Identificación: Mujer de 24 años, estudiante de posgrado originaria de Latinoamérica, residente en Madrid desde hace dos años. Consulta por crisis de angustia recurrentes, llanto inmotivado, sentimientos de extrañeza y parálisis académica ("siento que no pertenezco a este país pero que tampoco encajo ya cuando llamo a mi familia").

Evaluación Psicométrica VIA (Línea Base):

- **Media Dimensión Herencia = 3.90 / 9.00 puntos** (Baja vinculación; culpa por distanciamiento de costumbres tradicionales).
- **Media Dimensión Dominante (Mainstream) = 3.60 / 9.00 puntos** (Baja integración; inhibición social y vivencia de discriminación percibida).
- **Cuadrante de Adaptación: Marginación / Doble Rechazo Cultural** (estrés aculturativo severo).

Intervención Psicoterapéutica: 12 sesiones de psicoterapia afirmativa transcultural y Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Se abordó el duelo migratorio congelado, se promovió la participación en grupos interculturales universitarios y se legitimó la hibridación de su identidad como fortaleza personal.

Reevaluación a los 7 Meses: La Dimensión Herencia ascendió a **6.80/9.00** y la Dimensión Dominante a **7.20/9.00** (**Cuadrante de Integración / Biculturalismo**), remitiendo por completo los ataques de pánico y reanudando la defensa de su tesis doctoral.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

MARGINACIÓN VS. DEPRESIÓN MAYOR:

Un puntaje bajo en ambas dimensiones puede derivar de anhedonia y retraimiento depresivo general (descartar con PHQ-9). La anomia identitaria puede ser etiología o consecuencia del estrés.

SEPARACIÓN Y VIOLENCIA DE GÉNERO:

En mujeres migrantes en situación de Separación extrema (< 2.5 Mainstream), el desconocimiento del idioma y leyes receptoras agrava la vulnerabilidad frente al maltrato machista intrafamiliar.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Ryder, A. G., Alden, L. E., & Paulhus, D. L. (2000). Is acculturation unidimensional or bidimensional? A head-to-head comparison in the ethnic minority context. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(1), 49-65.
2. Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. *Applied Psychology: An International Review*, 46(1), 5-34.
3. Ozer, S. (2015). Predictors of psychological and sociocultural adaptation: A study of immigrants in Spain using the VIA. *International Journal of Intercultural Relations*, 49, 218-228.
4. Huynh, Q. L., Nguyen, A. M. D., & Benet-Martínez, V. (2018). Bicultural identity integration: A review of dimensions and outcomes. *Current Opinion in Psychology*, 18, 35-42.